



INSTRUCCIÓN INTERVENCIÓN CON ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS

Se establece la siguiente Instrucción, destinada a las Unidades Operativas, con intención de crear un protocolo interno que sirva como guía en las intervenciones policiales realizadas en la aplicación del “Protocolo de atención urgente y traslado de personas con posible enfermedad mental” del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación se centra en las actuaciones de auxilio y colaboración con los servicios sanitarios en la asistencia y traslado de **personas no detenidas** que necesiten atención psiquiátrica urgente.

2. TIPOS DE ACTUACIONES POLICIALES

La citada colaboración policial en este tipo de urgencias psiquiátricas será necesaria en las siguientes situaciones:

- 2.1. Auxilio al equipo sanitario en servicios de urgencia:** A requerimiento del personal médico, colaborando en la contención física de aquellos sujetos que, encontrándose en su domicilio o en un espacio comunitario, por sus alteraciones de conducta presenten riesgos de daño para sí mismos, otras personas o bienes, como paso previo a la intervención sanitaria para evaluación y decisiones sobre las medidas a seguir (contención psicológica o farmacológica, traslado, etc.), así como en el apoyo posterior para organizar el posible traslado, en la consideración de que en muchas ocasiones está médicamente contraindicada una contención farmacológica hasta que se haya establecido un diagnóstico correcto, colaborando si fuese necesario en el posterior traslado al Centro Hospitalario.
- 2.2. Auxilio en Centros sanitarios:** Colaboración en acontecimientos y circunstancias similares que se produzcan en un espacio sanitario como el de un Centro de Salud, cuando hayan quedado superados los medios de contención disponibles, de acuerdo con decisiones presididas por el sentido común, la idea del Servicio Público y por la prioridad de los intereses de los enfermos o posibles enfermos sobre otras consideraciones.
- 2.3. Petición policial para valoración psiquiátrica urgente:** En situaciones sobrevenidas en intervenciones policiales, cuando una dotación identifique a una persona que, por su conducta, necesite valoración psiquiátrica urgente, requiriendo en el lugar la personación de un equipo sanitario (médico y ambulancia). En su caso, si fuese necesario, hasta la llegada del personal facultativo, se podrán llevar a cabo las actuaciones de contención recogidas en



el punto 3.1.IV) de esta Instrucción, para evitar riesgos para sí mismo, otras personas o bienes.

- 2.4. **Colaboración en la localización y traslado urgente de un enfermo psiquiátrico:** Cuando el personal facultativo requiera, mediante informe médico, la colaboración de la Policía Local para localizar y trasladar de urgencia a un paciente para valoración o ingreso forzoso por razones psiquiátricas.

3. CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LAS ACTUACIONES POLICIALES

3.1. Contención física

Las dotaciones policiales que intervengan en este tipo de actuaciones deben tener en cuenta lo siguiente:

- I. **Prioridad de la asistencia sanitaria:** El objetivo principal de la actuación policial es garantizar la asistencia sanitaria necesaria.
- II. **Carácter subsidiario de la contención:** En muchas ocasiones, la sola presencia disuasoria es suficiente para conseguir la colaboración del paciente.
- III. **Auxilio a los servicios sanitarios:** Cuando la contención física sea inevitable, los servicios médicos decidirán la forma de realizarla, comenzando por la contención humana, es decir, mediante la sujeción por de las extremidades y de la cabeza de forma independiente, pasando posteriormente a la contención mecánica, o por otros medios específicos de sujeción, teniendo en cuenta que:
 - 1) Se debe evitar al máximo las tracciones de gran violencia
 - 2) Cuando se ha aplicado algún medio de comprensión (cuerdas, tiras, etc.) debe liberarse uno de los miembros cada media hora y de forma alternativa
 - 3) Si la persona tiene algún problema de pérdida de conciencia, intoxicadas o “ataques” deben ser sujetadas colocándolos apoyadas sobre el costado izquierdo y deben ser controlados por profesionales sanitarios lo antes posible, si no se encuentran presentes
- IV. **Contención por iniciativa de la dotación policial:** Cuando la dotación policial esté obligada a realizar actuaciones de contención, sin estar presentes los servicios médicos, hasta su llegada utilizarán los medios de control y compulsión de los que disponen, adecuando su actuación a cada situación de acuerdo a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.



3.2. Acompañamiento al transporte sanitario

El traslado de urgencia de un **enfermo psiquiátrico no detenido será ordenado por el médico in situ y se llevará a cabo siempre en una ambulancia** (salvo situaciones muy excepcionales). En su caso, en el traslado de enfermos agresivos que no puedan ser medicados previamente, cuando no resulte suficiente la escolta en el vehículo patrulla, un agente **podrá** acompañar en el interior de la ambulancia siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- I. El médico sea quien lo solicite
- II. Existan causas que lo justifiquen
- III. El traslado pueda realizarse con seguridad.

3.3. Traslados para valoración o ingreso psiquiátrico mediante informe del facultativo psiquiatra

La Policía Local podrá ser requerida para que realice el traslado de un enfermo a la Unidad Especializada de Psiquiatría del Hospital de Jove. El citado traslado será acordado mediante informe del Psiquiatra correspondiente y será entregado a esta policía para su localización, actuando con el siguiente orden:

- I. Una vez localizado, la dotación requerirá al paciente para que los acompañe al centro sanitario. **Si la conducta del paciente lo permite, será trasladado directamente en el propio vehículo patrulla.**
- II. Cuando los actuante adviertan que el paciente no quiere colaborar o se observen riesgos que impidan actuar de acuerdo al punto anterior (ej. enfermo muy agitado), se deberá requerir la presencia del facultativo responsable del informe o, en su caso, de cualquier otro médico, con los medios correspondientes para que decida sobre la urgencia y conveniencia del traslado.

3.4. Entradas en domicilio

Suele ser habitual que este tipo de intervenciones se lleven a cabo dentro del domicilio del propio enfermo, surgiendo dudas sobre cómo actuar ante la negativa del paciente a colaborar con los servicios de emergencia. Dentro de la regulación de la inviolabilidad del domicilio, se establecen una serie de causas que justifican el acceso a una vivienda en contra de la voluntad de su morador¹. Concretamente, para situaciones relacionadas con esta Instrucción, cuando sea necesario acceder al domicilio de un enfermo psiquiátrico que se niegue a cualquier tipo de asistencia y/o traslado, el artículo 15.2 de la LO 4/2015

¹ .-Recogido en la Constitución Española de 1978, art. 18.2; LECrim art. 553, LO 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, art. 15.2.



sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, recoge que “Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad”. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- i. Que la urgencia psiquiátrica debe ser declarada por el médico que acompañe a los actuantes (si no se encuentra en el lugar se debe solicitar su presencia a través del 112)
- ii. Que el objetivo prioritario es facilitar el acceso al personal facultativo para que traten y valoren al enfermo psiquiátrico.
- iii. Que no será necesario esperar a la llegada del personal médico en situaciones que obligan a una intervención inmediata de los agentes: casos de fragancia delictiva (Ej. Violencia de género o doméstica) o en situaciones de extrema gravedad (Ej. tentativas de suicidio).
- iv. Que en aquellas intervenciones en donde el acceso al domicilio de los actuantes pueda provocar una situación de mayor gravedad, se contactará con la Policía Nacional para valorar la presencia de un negociador en el lugar (ej. persona que amenaza con suicidarse si se entra a la vivienda).

3.5. **Comunicación de la actuación**

Se debe tener en cuenta que los responsables médicos tienen la obligación de comunicar el ingreso a la Autoridad Judicial en un plazo de 24 horas². Independientemente, la dotación actuante debe informar de la intervención policial realizada de la siguiente manera:

i. **Comparecencia en Inspección de Guardia**

Se realizará comparecencia en nuestra Inspección de Guardia en los siguientes supuestos:

- 1) Cuando se utilice una contención física reseñable
- 2) Cuando se acceda al domicilio sin consentimiento de su titular

ii. **Comparecencia en la ODAC de Policía Nacional**

Se realizará comparecencia en la ODAC en los siguientes supuestos:

- 1) Que el enfermo, en situación sobrevenida, **sea responsable de algún delito**, por ejemplo:

2.- Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 763



- a) Violencia de género o doméstica
- b) Daños intencionados
- c) Atentado sobre los actuantes: Solo en aquellos casos en donde el paciente agrede con dolo sobre los actuantes.
- d) Otros delitos...

En estos casos, aunque el enfermo pueda ser inimputable (hecho que valorará posteriormente la Autoridad Judicial), sigue siendo responsable de un delito que puede dar lugar a su detención. Por tanto, cuando proceda, se realizará custodia del detenido (normalmente en el Hospital de Jove) hasta que el psiquiatra decida si queda ingresado, participando a la ODAC todo lo actuado.

- 2) Intentos de suicidio:** Cuando los hechos observados objetivamente muestren evidencias autolíticas graves.

iii. **Informe interno**

Por último, se realizará un informe interno en el resto de situaciones:

- 1) Traslado del enfermo en ambulancia sin incidencias reseñables
- 2) Traslado voluntario por informe médico en vehículo patrulla